

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22222628292 / 234

AIRTON FERNANDES DE OLIVEIRA

IDADE: 80 a. PESO: 71 ALTURA: 168 PROFISSÃO: Planejamento - Apos.
SINTOMAS: Sonolência - Acorda engasgado - Boca seca
QUEIXAS: Pernas inchadas - Esquecimento
MEDICAMENTOS: Korus - Glifage^(2x) Hidroclorotiazida - Pantoprazol
AAS / Copidozol / Adiphet / Selozyk / Aitrovast. - Insulina
MÉDICO: Dr. Pedro

MARCAPASSO: ☒ SIM () NÃO / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () SIM ☒ NÃO

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x natação

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 (16h) LANCHE: 5 JANTAR: 5

HORA QUE DORME: 02

HORA QUE ACORDA: 10:00

COCHILO ☒ SIM () NÃO

DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () NÃO X NA SEMANA () NÃO

Esposa Ronca

FUMO () SIM () NÃO / DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 2x a 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: IV

IAH: 45.3

SPO2: 86%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Retração vesícula

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

Fratura maxilar (há 40a)

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Dor joelho (E).

03/05/24 - Avaliação

10/05/24 - P = 5-10 cmH₂O 7,3 cmH₂O (mediano)

IAH = 7,4 c/h

m. de uso: 7h 2m

fuga: 19 l/m

sem adaptação

Natacha

20/05/24 P = 8.6 cmH₂O

IAH = 11.8

m. de uso: 7h 50'

compreu elite

fua

05/05/24 P = 9.8 cmH₂O

m. de uso: 8h 14'

IAH = 10.3

fuga = 47.2 lpm.

19/05/24 P = 9.8 cmH₂O

IAH = 21.8

m. de uso: 7h 37'

fuga = 33.0 lpm.

Mascara fora do lugar

fua

Silvia

$$\begin{aligned} 02/07 \quad P &= 10.4 \\ IAH &= 10.1 - (AC=2.9 / IH=6.1 / IA=4.0) \\ 25 \quad m. de uso &= 7h40' \\ fuga &= 27.9 \end{aligned}$$

fuga

Nome: AIRTON FERNANDES OLIVEIRA
Data de Nascimento: 17-4-1944
IMC: 25,16
Sexo: Masculino
Data do exame: 19-01-2024

Peso: 71 kg
Altura: 1,68 m
Médico: DR. PEDRO MACEDO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 19-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 560,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 17,0 e 108,5 minutos. O tempo total de sono foi de 481,0 min, eficiência de 85,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 63,7%; estágio N3: 16,5%; sono REM: 17,3%. O índice de despertares foi de 28,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 45,3/hora, sendo 93 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 47 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 86%, permanecendo 2,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 61 bpm e NREM de 57 - 61 bpm.

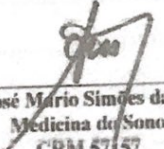
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 45,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=86%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. registro de ronco durante o sono.

**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.
Presença de bruxismo ou apertamento.**

IAH: 05-15 /hora leve. ← até 5 e 1/2
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157